



Distúrbios cognitivos

É uma patologia bastante explorada em idosos atualmente, devido ao aumento da incidência e também por ser um fator de predisposição para demências como Alzheimer ou demência vascular.

Podemos dividir os acometimentos cognitivos em:

- **Declínio subjetivo:** queixas cognitivas leves (memória), com testes normais (mocha, minimento);
- **Transtorno neurocognitivo leve:** queixas cognitivas além da memória, com testes alterados, sem dificuldade de realizar as atividades de vida diárias e com discreta alteração de atividades instrumentais;
- **Demência:** testes alterados com alterações instrumentais e nas atividades de vida diária.

Geralmente, no envelhecimento normal da cognição há alguns prejuízos discretos, mas se mantém e não pioram. Quando atrapalha nas atividades de vida diárias já é um processo demencial!

Cognição envolve:

- Memória: capacidade de armazenamento de informações;
- Praxia: capacidade de executar um ato motor;
- Função executiva: capacidade de planejamento e execução de tarefas complexas;
- Linguagem: capacidade de compreensão e expressão da linguagem oral e escrita. Inclusive, uma das primeiras coisas que o Alzheimer afeta é a escrita;
- Função visuoespacial: capacidade de localização no espaço.

Declínio cognitivo subjetivo (DCS)

Pacientes com DCS podem permanecer estáveis, ter uma reversão ou evoluir para demência. Não somente as demências podem ser as causas de DCS, mas também:

- Envelhecimento normal;

- Depressão e ansiedade;
- Traços de personalidade;
- Transtorno do sono: dormir mal a noite, especialmente apneia e insônia;
- Uso de medicamentos com ação anticolinérgica, gabaérgica (benzodiazepínicos) e zolpidem.

Os pacientes com DCS com maior risco para demência:

- Idosos com queixas progressivas de perda cognitiva dentro dos últimos 5 anos: piora ao longo do tempo;
- Paciente está preocupado com esse declínio;
- Familiares confirmando esse quadro.

Com o envelhecimento há redução da memória recente, então podem ter lentificação a guardar informações, esquecer nomes. Mas sempre que vem queixas cognitivas devemos avaliar depressão, sono, afetando outras condições que podem comprometer o cognitivo.

Transtorno neurocognitivo leve

▼ Definição e epidemiologia

É a **lacuna entre o envelhecimento normal e a demência**, basicamente o indivíduo não é normal, mas não preenche os critérios para demência.

Ocorre em 10 a 20% dos indivíduos com >65 anos. A progressão para demência em indivíduos com TNL foi 9,6%, 14 vezes maior do que foi encontrada na população normal.

Alguns indivíduos ficam estáveis e 14% deles podem reverter ao normal.

Num estudo com 874 idosos com CCL, com um seguimento médio de 7,9 anos, 47% desenvolveram demência e 39% mantiveram o diagnóstico.

As **atividades de vida diárias preservadas** (tomar banho, comer, se vestir), funções **instrumentais complexas intactas ou discretamente alteradas** (ligar TV, cozinhar, c). Não se restringe a alteração de memória na parte cognitiva, pode ser amnésico ou não mnésico. Mas, os **testes de memória estão comprometidos**.

A **demência** interfere nas atividades funcionais, com declínio em relação a níveis prévios de funcionamento. Não se explica por um delírium ou doença psiquiátrica.

Detectado por anamnese pelo paciente ou informante, geralmente o paciente não percebe. Os **comprometimentos cognitivos ou comportamentais afetam no mínimo dois**: memória, funções executivas, habilidades visuoespaciais, linguagem; alteração da personalidade ou comportamento.

▼ Diagnóstico

Critérios diagnósticos:

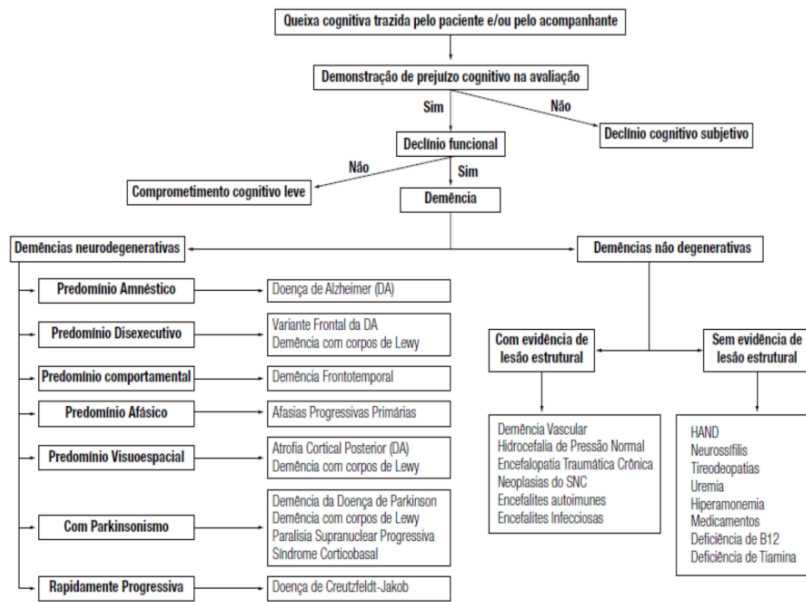
1. Queixa de déficit de memória, preferencialmente vista por familiares que convivem com o paciente.
2. Caracterização de diminuição de memória ou outros domínios cognitivos avaliado por testes cognitivos, abaixo do esperado para sua idade e nível educacional;
3. Habilidade preservada para realização das atividades de vida diária ou comprometimento mínimo da habilidade instrumental de vida diária;
4. Funcionamento cognitivo global preservado;
5. Ausência de demência.

Conforme a parte cognitiva é afetada podemos classificar pelos CCL. Então: há comprometimento da memória?

Se sim → TNL amnésico. Pode ser único domínio alterado ou ter múltiplos domínios alterados.

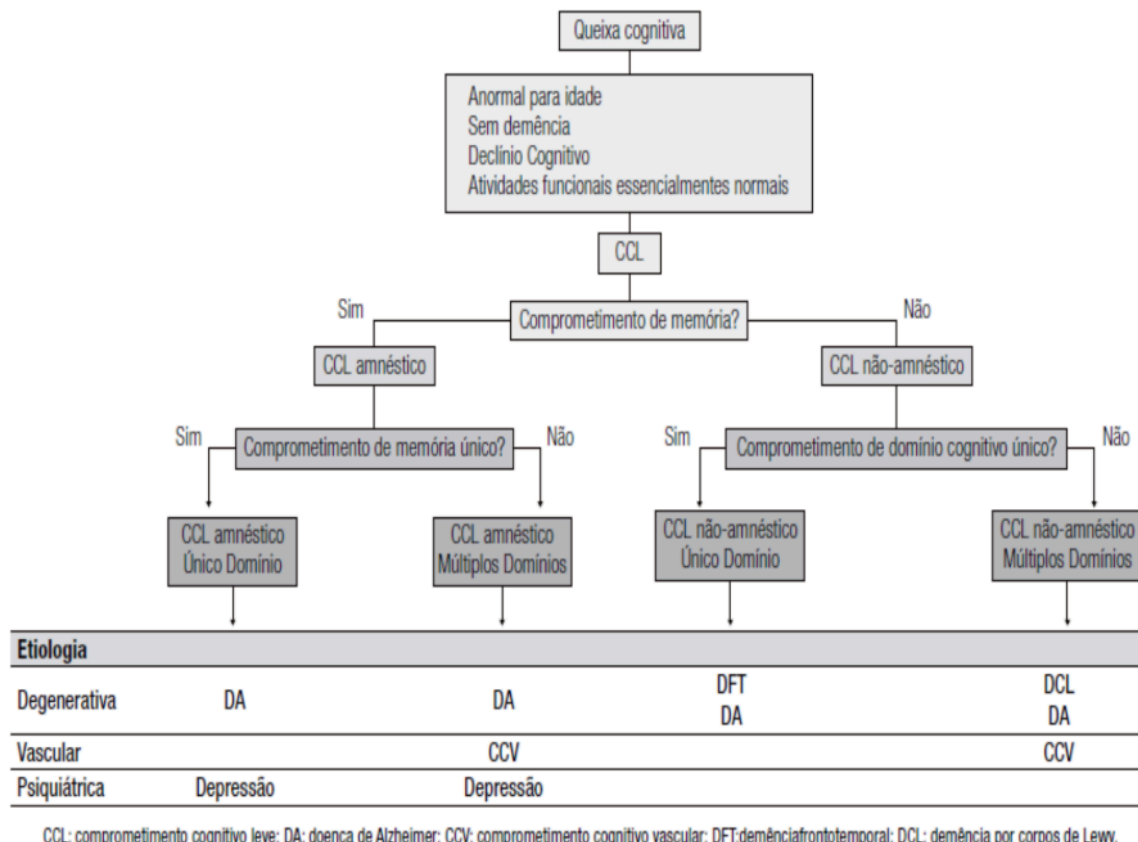
Se não → TNL não amnésico. Pode ser único domínio alterado, exceto memória, ou pode ter múltiplos domínios alterados.

Muitos dos pacientes evoluem para processos demenciais:



- Se predomínio amnésico → facilita Alzheimer;
- Se predomínio disexecutivo → facilita variante frontal da demência de Alzheimer e demência com corpos de Lewy;
- Se predomínio comportamental → facilita demência frontotemporal;
- Se predomínio afásico → facilita afásias progressivas primárias;
- Se predomínio visuoespacial → facilita atrofia cortical posterior da doença de Alzheimer, demência de corpos de Lewy;
- Se com parkinsonismo → facilita demência da doença de Parkinson, demência com corpos de Lewy, paralisia supranuclear progressiva e síndrome corticobasal;
- Se rapidamente progressiva → facilita doença de Creutzfeldt-Jacob.

▼ Classificação



▼ TNL amnésico

Os pacientes com TNL amnésico apresentam mais comorbidades que os indivíduos normais, como DM, HAS, doença cardíaca.

▼ Único domínio afetado

É o subtipo mais comum e, em grande parte dos casos, apresenta-se como **precursor do Alzheimer**.

▼ Múltiplos domínios afetados

Engloba indivíduos que têm problema de memória e outro domínio cognitivo, também podem evoluir para Alzheimer.

Indivíduos com essa condição têm grande probabilidade de evoluir para **DA ou demência vascular**, porém, a reversão para cognição normal tem sido documentada em alguns casos, especialmente se muda os hábitos de vida.

▼ TNL não amnésico

▼ Único domínio afetado

Pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais. Uma proporção desses pacientes pode evoluir para:

- **Demência frontotemporal;**
- **Demência com corpos de Lewy;**
- **Paralisia supranuclear progressiva;**
- **Degeneração corticobasal.**

Obs: sendo esses 3 últimos com um componente de parkinsonismo.

▼ **Múltiplos domínios afetados**

Pode estar associado a:

- **Demência frontotemporal** (não tem tanto comprometimento de memória, tem mais alterações psiquiátricas);
- **Demência com corpos de Lewy** (parkinsonismo, alterações cognitivas, alucinações, alteração de função executiva).

Existe o **TNL vascular** em que o paciente apresenta microinfartos cerebrais, podendo evoluir para **DA ou demência mista** (vascular + DA).

Geralmente são pacientes com bradipsiquismo, empobrecimento do pensamento abstrato, alterações de linguagem, atenção, memória episódica e do trabalho, alterações das funções executivas.

▼ **Avaliação de um paciente com suspeita de TNL**

1. Colher uma história detalhada com paciente e terceiros (cuidador), incluindo a avaliação funcional, para saber se preenche os critérios para TNL;
2. Verificar se há medicamentos em uso (antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, anticolinérgicos), sintomas psiquiátricos ou anormalidades neurológicas que possam ser causa do TNL;
3. Aplicar testes cognitivos para avaliar, objetivamente, o déficit cognitivo relatado pelo paciente e/ou por terceiro, registrando, caso existente, o grau de comprometimento cognitivo e os domínios afetados;
4. Realizar exames laboratoriais e, eventualmente, de imagem;
5. Avaliar o prognóstico;
6. Estabelecer com o paciente e a família um plano de tratamento e acompanhamento.

▼ História clínica

Verificar se o paciente usa **medicamentos**, se tem **sintomas** psiquiátricos ou alterações neurológicas.

Os medicamentos mais implicados na função cognitiva são: opióides, tricíclicos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, indutores do sono não benzodiazepínico (zolpidem), anti-histamínicos (diminidratos), relaxantes musculares, antiepilépticos.

Avaliar a **audição e a visão**, bem como distúrbios do **sono**.

Investigar alguma causa secundária ao sintoma, como sintomas depressivos, trauma craniano (hematoma subdural), alterações psicóticas e comportamentais, alucinações e possível convulsão.

▼ Testes cognitivos

O teste cognitivo com **melhor acurácia no TNL foi o MoCA** Teste.

Pontuação de corte 25/26 no TNL, então menos que isso a chance de ser um quadro demencial é maior.

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA)
Versão Experimental Brasileira

Nome: _____ Data de nascimento: ____/____/____
Educação: _____ Data de avaliação: ____/____/____
Sexo: _____ Idade: _____

ESPACIAL / EXECUTIVA Copiar o cubo Desenhar um RELÓGIO (once horas e dez minutos) (3 pontos)		Pontos
NOMEAÇÃO [] [] []		5
MEMÓRIA Leia a lista de palavras. O sujeito deve repetir cada uma das palavras em voz alta. Não se deve repetir nenhuma palavra. (1 ponto por palavra correta) F B A C B I N A A J K L B A F A R D E A A J A M O F A A B		5
ATENÇÃO Leia a série de letras. O sujeito deve falar com a mão esquerda cada vez que aparecer a letra "A". Não se devem contar pontos se > 2 erros. [] F B A C B I N A A J K L B A F A R D E A A J A M O F A A B		2
LINGUAGEM Responda às perguntas seguintes. (1 ponto por resposta correta) 1. Qual o nome do animal que vive no deserto? 2. Qual o nome do animal que vive no mar? 3. Qual o nome do animal que vive no céu? 4. Qual o nome do animal que vive na terra? 5. Qual o nome do animal que vive no rio? 6. Qual o nome do animal que vive no lago? 7. Qual o nome do animal que vive no campo? 8. Qual o nome do animal que vive na montanha? 9. Qual o nome do animal que vive no deserto? 10. Qual o nome do animal que vive no mar? 11. Qual o nome do animal que vive no céu? 12. Qual o nome do animal que vive na terra? 13. Qual o nome do animal que vive no rio? 14. Qual o nome do animal que vive no lago? 15. Qual o nome do animal que vive no campo? 16. Qual o nome do animal que vive na montanha? 17. Qual o nome do animal que vive no deserto? 18. Qual o nome do animal que vive no mar? 19. Qual o nome do animal que vive no céu? 20. Qual o nome do animal que vive na terra? 21. Qual o nome do animal que vive no rio? 22. Qual o nome do animal que vive no lago? 23. Qual o nome do animal que vive no campo? 24. Qual o nome do animal que vive na montanha? 25. Qual o nome do animal que vive no deserto? 26. Qual o nome do animal que vive no mar? 27. Qual o nome do animal que vive no céu? 28. Qual o nome do animal que vive na terra? 29. Qual o nome do animal que vive no rio? 30. Qual o nome do animal que vive no lago? 31. Qual o nome do animal que vive no campo? 32. Qual o nome do animal que vive na montanha? 33. Qual o nome do animal que vive no deserto? 34. Qual o nome do animal que vive no mar? 35. Qual o nome do animal que vive no céu? 36. Qual o nome do animal que vive na terra? 37. Qual o nome do animal que vive no rio? 38. Qual o nome do animal que vive no lago? 39. Qual o nome do animal que vive no campo? 40. Qual o nome do animal que vive na montanha? 41. Qual o nome do animal que vive no deserto? 42. Qual o nome do animal que vive no mar? 43. Qual o nome do animal que vive no céu? 44. Qual o nome do animal que vive na terra? 45. Qual o nome do animal que vive no rio? 46. Qual o nome do animal que vive no lago? 47. Qual o nome do animal que vive no campo? 48. Qual o nome do animal que vive na montanha? 49. Qual o nome do animal que vive no deserto? 50. Qual o nome do animal que vive no mar? 51. Qual o nome do animal que vive no céu? 52. Qual o nome do animal que vive na terra? 53. Qual o nome do animal que vive no rio? 54. Qual o nome do animal que vive no lago? 55. Qual o nome do animal que vive no campo? 56. Qual o nome do animal que vive na montanha? 57. Qual o nome do animal que vive no deserto? 58. Qual o nome do animal que vive no mar? 59. Qual o nome do animal que vive no céu? 60. Qual o nome do animal que vive na terra? 61. Qual o nome do animal que vive no rio? 62. Qual o nome do animal que vive no lago? 63. Qual o nome do animal que vive no campo? 64. Qual o nome do animal que vive na montanha? 65. Qual o nome do animal que vive no deserto? 66. Qual o nome do animal que vive no mar? 67. Qual o nome do animal que vive no céu? 68. Qual o nome do animal que vive na terra? 69. Qual o nome do animal que vive no rio? 70. Qual o nome do animal que vive no lago? 71. Qual o nome do animal que vive no campo? 72. Qual o nome do animal que vive na montanha? 73. Qual o nome do animal que vive no deserto? 74. Qual o nome do animal que vive no mar? 75. Qual o nome do animal que vive no céu? 76. Qual o nome do animal que vive na terra? 77. Qual o nome do animal que vive no rio? 78. Qual o nome do animal que vive no lago? 79. Qual o nome do animal que vive no campo? 80. Qual o nome do animal que vive na montanha? 81. Qual o nome do animal que vive no deserto? 82. Qual o nome do animal que vive no mar? 83. Qual o nome do animal que vive no céu? 84. Qual o nome do animal que vive na terra? 85. Qual o nome do animal que vive no rio? 86. Qual o nome do animal que vive no lago? 87. Qual o nome do animal que vive no campo? 88. Qual o nome do animal que vive na montanha? 89. Qual o nome do animal que vive no deserto? 90. Qual o nome do animal que vive no mar? 91. Qual o nome do animal que vive no céu? 92. Qual o nome do animal que vive na terra? 93. Qual o nome do animal que vive no rio? 94. Qual o nome do animal que vive no lago? 95. Qual o nome do animal que vive no campo? 96. Qual o nome do animal que vive na montanha? 97. Qual o nome do animal que vive no deserto? 98. Qual o nome do animal que vive no mar? 99. Qual o nome do animal que vive no céu? 100. Qual o nome do animal que vive na terra?		10
ABSTRAÇÃO Responda às perguntas seguintes. (1 ponto por resposta correta) 1. Qual o nome do animal que vive no deserto? 2. Qual o nome do animal que vive no mar? 3. Qual o nome do animal que vive no céu? 4. Qual o nome do animal que vive na terra? 5. Qual o nome do animal que vive no rio? 6. Qual o nome do animal que vive no lago? 7. Qual o nome do animal que vive no campo? 8. Qual o nome do animal que vive na montanha? 9. Qual o nome do animal que vive no deserto? 10. Qual o nome do animal que vive no mar? 11. Qual o nome do animal que vive no céu? 12. Qual o nome do animal que vive na terra? 13. Qual o nome do animal que vive no rio? 14. Qual o nome do animal que vive no lago? 15. Qual o nome do animal que vive no campo? 16. Qual o nome do animal que vive na montanha? 17. Qual o nome do animal que vive no deserto? 18. Qual o nome do animal que vive no mar? 19. Qual o nome do animal que vive no céu? 20. Qual o nome do animal que vive na terra? 21. Qual o nome do animal que vive no rio? 22. Qual o nome do animal que vive no lago? 23. Qual o nome do animal que vive no campo? 24. Qual o nome do animal que vive na montanha? 25. Qual o nome do animal que vive no deserto? 26. Qual o nome do animal que vive no mar? 27. Qual o nome do animal que vive no céu? 28. Qual o nome do animal que vive na terra? 29. Qual o nome do animal que vive no rio? 30. Qual o nome do animal que vive no lago? 31. Qual o nome do animal que vive no campo? 32. Qual o nome do animal que vive na montanha? 33. Qual o nome do animal que vive no deserto? 34. Qual o nome do animal que vive no mar? 35. Qual o nome do animal que vive no céu? 36. Qual o nome do animal que vive na terra? 37. Qual o nome do animal que vive no rio? 38. Qual o nome do animal que vive no lago? 39. Qual o nome do animal que vive no campo? 40. Qual o nome do animal que vive na montanha? 41. Qual o nome do animal que vive no deserto? 42. Qual o nome do animal que vive no mar? 43. Qual o nome do animal que vive no céu? 44. Qual o nome do animal que vive na terra? 45. Qual o nome do animal que vive no rio? 46. Qual o nome do animal que vive no lago? 47. Qual o nome do animal que vive no campo? 48. Qual o nome do animal que vive na montanha? 49. Qual o nome do animal que vive no deserto? 50. Qual o nome do animal que vive no mar? 51. Qual o nome do animal que vive no céu? 52. Qual o nome do animal que vive na terra? 53. Qual o nome do animal que vive no rio? 54. Qual o nome do animal que vive no lago? 55. Qual o nome do animal que vive no campo? 56. Qual o nome do animal que vive na montanha? 57. Qual o nome do animal que vive no deserto? 58. Qual o nome do animal que vive no mar? 59. Qual o nome do animal que vive no céu? 60. Qual o nome do animal que vive na terra? 61. Qual o nome do animal que vive no rio? 62. Qual o nome do animal que vive no lago? 63. Qual o nome do animal que vive no campo? 64. Qual o nome do animal que vive na montanha? 65. Qual o nome do animal que vive no deserto? 66. Qual o nome do animal que vive no mar? 67. Qual o nome do animal que vive no céu? 68. Qual o nome do animal que vive na terra? 69. Qual o nome do animal que vive no rio? 70. Qual o nome do animal que vive no lago? 71. Qual o nome do animal que vive no campo? 72. Qual o nome do animal que vive na montanha? 73. Qual o nome do animal que vive no deserto? 74. Qual o nome do animal que vive no mar? 75. Qual o nome do animal que vive no céu? 76. Qual o nome do animal que vive na terra? 77. Qual o nome do animal que vive no rio? 78. Qual o nome do animal que vive no lago? 79. Qual o nome do animal que vive no campo? 80. Qual o nome do animal que vive na montanha? 81. Qual o nome do animal que vive no deserto? 82. Qual o nome do animal que vive no mar? 83. Qual o nome do animal que vive no céu? 84. Qual o nome do animal que vive na terra? 85. Qual o nome do animal que vive no rio? 86. Qual o nome do animal que vive no lago? 87. Qual o nome do animal que vive no campo? 88. Qual o nome do animal que vive na montanha? 89. Qual o nome do animal que vive no deserto? 90. Qual o nome do animal que vive no mar? 91. Qual o nome do animal que vive no céu? 92. Qual o nome do animal que vive na terra? 93. Qual o nome do animal que vive no rio? 94. Qual o nome do animal que vive no lago? 95. Qual o nome do animal que vive no campo? 96. Qual o nome do animal que vive na montanha? 97. Qual o nome do animal que vive no deserto? 98. Qual o nome do animal que vive no mar? 99. Qual o nome do animal que vive no céu? 100. Qual o nome do animal que vive na terra?		10
ORIENTAÇÃO Responda às perguntas seguintes. (1 ponto por resposta correta) 1. Qual o nome do animal que vive no deserto? 2. Qual o nome do animal que vive no mar? 3. Qual o nome do animal que vive no céu? 4. Qual o nome do animal que vive na terra? 5. Qual o nome do animal que vive no rio? 6. Qual o nome do animal que vive no lago? 7. Qual o nome do animal que vive no campo? 8. Qual o nome do animal que vive na montanha? 9. Qual o nome do animal que vive no deserto? 10. Qual o nome do animal que vive no mar? 11. Qual o nome do animal que vive no céu? 12. Qual o nome do animal que vive na terra? 13. Qual o nome do animal que vive no rio? 14. Qual o nome do animal que vive no lago? 15. Qual o nome do animal que vive no campo? 16. Qual o nome do animal que vive na montanha? 17. Qual o nome do animal que vive no deserto? 18. Qual o nome do animal que vive no mar? 19. Qual o nome do animal que vive no céu? 20. Qual o nome do animal que vive na terra? 21. Qual o nome do animal que vive no rio? 22. Qual o nome do animal que vive no lago? 23. Qual o nome do animal que vive no campo? 24. Qual o nome do animal que vive na montanha? 25. Qual o nome do animal que vive no deserto? 26. Qual o nome do animal que vive no mar? 27. Qual o nome do animal que vive no céu? 28. Qual o nome do animal que vive na terra? 29. Qual o nome do animal que vive no rio? 30. Qual o nome do animal que vive no lago? 31. Qual o nome do animal que vive no campo? 32. Qual o nome do animal que vive na montanha? 33. Qual o nome do animal que vive no deserto? 34. Qual o nome do animal que vive no mar? 35. Qual o nome do animal que vive no céu? 36. Qual o nome do animal que vive na terra? 37. Qual o nome do animal que vive no rio? 38. Qual o nome do animal que vive no lago? 39. Qual o nome do animal que vive no campo? 40. Qual o nome do animal que vive na montanha? 41. Qual o nome do animal que vive no deserto? 42. Qual o nome do animal que vive no mar? 43. Qual o nome do animal que vive no céu? 44. Qual o nome do animal que vive na terra? 45. Qual o nome do animal que vive no rio? 46. Qual o nome do animal que vive no lago? 47. Qual o nome do animal que vive no campo? 48. Qual o nome do animal que vive na montanha? 49. Qual o nome do animal que vive no deserto? 50. Qual o nome do animal que vive no mar? 51. Qual o nome do animal que vive no céu? 52. Qual o nome do animal que vive na terra? 53. Qual o nome do animal que vive no rio? 54. Qual o nome do animal que vive no lago? 55. Qual o nome do animal que vive no campo? 56. Qual o nome do animal que vive na montanha? 57. Qual o nome do animal que vive no deserto? 58. Qual o nome do animal que vive no mar? 59. Qual o nome do animal que vive no céu? 60. Qual o nome do animal que vive na terra? 61. Qual o nome do animal que vive no rio? 62. Qual o nome do animal que vive no lago? 63. Qual o nome do animal que vive no campo? 64. Qual o nome do animal que vive na montanha? 65. Qual o nome do animal que vive no deserto? 66. Qual o nome do animal que vive no mar? 67. Qual o nome do animal que vive no céu? 68. Qual o nome do animal que vive na terra? 69. Qual o nome do animal que vive no rio? 70. Qual o nome do animal que vive no lago? 71. Qual o nome do animal que vive no campo? 72. Qual o nome do animal que vive na montanha? 73. Qual o nome do animal que vive no deserto? 74. Qual o nome do animal que vive no mar? 75. Qual o nome do animal que vive no céu? 76. Qual o nome do animal que vive na terra? 77. Qual o nome do animal que vive no rio? 78. Qual o nome do animal que vive no lago? 79. Qual o nome do animal que vive no campo? 80. Qual o nome do animal que vive na montanha? 81. Qual o nome do animal que vive no deserto? 82. Qual o nome do animal que vive no mar? 83. Qual o nome do animal que vive no céu? 84. Qual o nome do animal que vive na terra? 85. Qual o nome do animal que vive no rio? 86. Qual o nome do animal que vive no lago? 87. Qual o nome do animal que vive no campo? 88. Qual o nome do animal que vive na montanha? 89. Qual o nome do animal que vive no deserto? 90. Qual o nome do animal que vive no mar? 91. Qual o nome do animal que vive no céu? 92. Qual o nome do animal que vive na terra? 93. Qual o nome do animal que vive no rio? 94. Qual o nome do animal que vive no lago? 95. Qual o nome do animal que vive no campo? 96. Qual o nome do animal que vive na montanha? 97. Qual o nome do animal que vive no deserto? 98. Qual o nome do animal que vive no mar? 99. Qual o nome do animal que vive no céu? 100. Qual o nome do animal que vive na terra?		10
TOTAL Adicione 1 ponto se o sujeito for > 65 anos de idade.		30

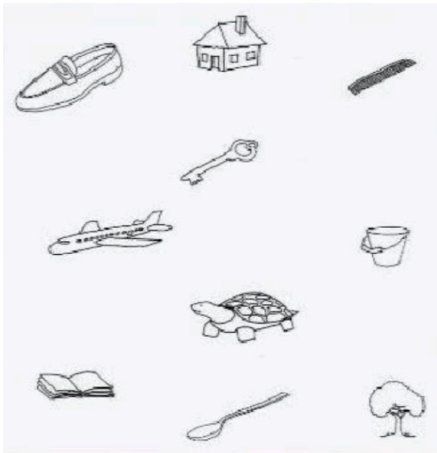
© Z. Nasreddine MD www.mocatest.org
Versão experimental Brasileira: Ana Lúcia Rosa Sarmento
Paulo Henrique Ferreira Bertolucci - José Roberto Wajman
UNIFESP-SP 2007

O **MEEM** tem uma sensibilidade baixa no diagnóstico de TNL, pois geralmente esses pacientes vão muito bem no MEEM, acontecendo também com o teste de fluência verbal e teste do relógio.

O **10 CS** também pode auxiliar em TNL ou suspeita de demência, quanto pior o escore maior o risco.

Dentro desse teste tem o **teste de fluência verbal**, em que pedimos o maior numero de animais que conseguir, o mais rápido possível, vale qualquer bicho mas não pode ser o mesmo, por exemplo boi e vaga, marcamos quantas falam em 1 minuto. Quanto mais palavras falar, melhor.

Lembrar que tem **influencia da escolaridade**, se for muito baixa não é possível ser feito, ai podemos fazer o **teste de figuras**, mostra a folha com figuras (pode ajudar o paciente a identificar os objetos se for preciso), tira e pede quais eram os desenhos, faz 3 vezes, o número de acertos deve aumentar, se não aumentar ou piorar indica um distúrbio.



Com isso, o CDR classifica os pacientes em leve moderada e grave, e questionável quando é um comprometimento cognitivo leve:

	Nenhuma 0	Questionável 0,5	Leve 1	Moderada 2	Grave 3
Assuntos comunitários	Funcionalmente independente ao nível usual de trabalho, compras, atividades voluntárias e grupos sociais	Leve incapacidade nestas atividades	Incapaz de funcionar independentemente nestas atividades, ainda que possa se engajar em algumas. Parece normal quando casualmente inspecionado.	Sem pretensão de manter funções independentes fora do domicílio. Parece suficientemente bem para ser levado à atividades fora do domicílio familiar.	Parece muito doente para ser levado para fora do domicílio
Atividades domésticas e passatempos	Vida doméstica, passatempo e interesse intelectual, bem mantidos.	Vida doméstica, passatempo e interesse intelectual levemente comprometido.	Incapacidade leve, porém definitiva, para atividades do lar. Abandono de atividades mais difíceis, passatempos complicados. Outros interesses abandonados.	Somente as ações simples estilo preservadas; interesse restrito.	Ausência de atividades significativas no domicílio.
Cuidado pessoal	Plenamente capaz de manter auto-cuidado		Necessita "incentivo"	Requer assistência no vestuário, higiene e manejo de itens pessoais.	Requer muita ajuda no cuidado pessoal; incontinência freqüente.
Julgamento e resolução de problema	Resolve problemas do dia-a-dia, incluindo atividades comerciais e financeiras; capacidade de julgamento adequado quando comparada ao desempenho anterior	Incapacidade leve, para resolver problemas; identificar similaridades e diferenças	Dificuldade moderada no manejo de problemas, identificação de similaridades e diferenças. Julgamento social usualmente preservado.	Enorme incapacidade para manejar problemas, similaridades e diferenças. Julgamento social comprometido.	Incapaz de fazer julgamentos ou resolver problemas.
Memória	Sem perda de memória; esquecimento inconstante	Esquecimento leve, consistente, parcialmente "Esquecimento benigno"	Perda moderada da memória, mais acentuada para eventos recentes. Interferência nas atividades da vida diária.	Perda grave da memória, com retenção apenas de dados fortemente consolidados, novos dados rapidamente perdidos	Grave perda da memória, apenas fragmentos permanecem.
Orientação	Orientação plena	Orientação plena, exceto dificuldade branda com datas.	Dificuldade moderada com datas, orientação quanto ao "espaço" onde se realiza exame; pode apresentar desorientação geográfica.	Dificuldade grave com datas, desorientação usual quanto ao tempo. Permanece quanto ao espaço.	Orientação apenas em relação à pessoa.

Podemos encaminhar o paciente para uma **neuropsicóloga** em duvida de TNL ou demência, pois usa mais testes do que nos usamos, demorando semanas para formar o laudo.

▼ **Exames laboratoriais**

Pedimos quando o paciente tem alterações cognitivas, pois patologias podem afetar a cognição:

- Glicemia jejum: hipoglicemia;
- TSH e T4 livre;
- Hemograma;
- Cálcio;
- Ureia, creatinina;
- Função hepática;
- B12, ácido fólico: deficiência pode causar distúrbios. Cuidar para não cegar o diagnóstico nisso, repomos B12 e observamos, pois pode ter outro problema associado;
- HIV: especialmente idosos <70 anos;
- Magnésio;
- Homocisteína: aumenta no déficit de B12, aumentando o risco de distúrbios cognitivos;
- Sorologia para sífilis: suspeita de neurosífilis.

As causas potencialmente reversíveis de TNL incluem:

- Hipo/hipermagnesemia;
- Hipo/hiperglicemia;
- Hipo/hipercalcemia;
- Hipo/hipertireoidismo;
- Insuficiência renal ou hepática;
- Deficiência de vitaminas;
- Infecções.

Além disso, podemos fazer **dosagem de proteína beta-amilóide e proteína tau no líquido**. Então, se encontrados níveis baixos de proteína Beta Amilóide e elevados de proteína Tau indica maior risco para DA.

▼ Exames de imagem

RNM de encéfalo: medidas do volume dos hipocampos. Hipotrofia pode sugerir demência.

PET amiloide/RNM com composto B de pittsburgh: calcula o volume de proteína Beta-amilóide depositada no cérebro. Na DA terá uma quantidade muito maior do que em um cérebro maior.

▼ Evolução

A evolução de TNL para demência depende da:

- **Idade:** quanto maior a idade, maior a probabilidade de evolução para demência;
- **Intensidade e heterogeneidade do déficit:** aqueles com escores mais comprometidos nos testes cognitivos e com maior envolvimento de domínios cognitivos apresentam maior probabilidade de progressão para demência;
- **Atrofia do lobo temporal medial:** um marcador de processo neurodegenerativo que pode ser registrado já na fase pré- sintomática da DA . Em pacientes com CCL amnésico, essa alteração estrutural é também observada. Contudo, o mesmo não tem sido registrado no CCL não amnésico com múltiplos domínios;
- **Intensidade da atrofia temporal medial:** diretamente relacionada ao risco de demência. A avaliação visual por meio de escalas padronizadas pode se mostrar razoavelmente válida. Técnicas para mensuração objetiva e quantitativa da atrofia vêm sendo desenvolvidas;
- **RMN com hiperintensidade de sinal na substancia branca e/ou infarto cortical:** associada a maior risco evolutivo para demência mista ou vascular.

▼ Fatores preditores para DA

Pacientes com TNL e que apresentam essas características são forte indicadores para doença de Alzheimer:

1. Presença de biomarcadores liquóricos;
2. Atrofia mesmo que discreta das regiões mesiais do lobo temporal (hipocampo) e córtex entorrinal;
3. PET amiloide alterado;
4. Presença de Alelo E4.

▼ Tratamento

▼ Não farmacológico

Não existe medicação para tratar o transtorno neurocognitivo leve. Mas alguns fatores podem auxiliar:

- **Atividade física:**

Estudo demonstrou que as atividades físicas coletivas, com duração de 1 hora por dia e frequência de 2 vezes por semana (caminhadas, treinos de equilíbrio, força e flexibilidade) estão associadas a melhor evolução do status funcional de pacientes idosos com DA leve e moderada, residentes em instituições de longa permanência. Tais pacientes apresentaram uma significativa redução da velocidade.

A prática de atividade física aeróbica reduziu na RMN a progressão da atrofia medial temporal, e até aumento do volume hipocampal.

Quanto mais força nas pernas, maior mobilidade e maior cognição.

- **Dieta mediterrânea:**

Uma investigação com 1.393 voluntários idosos, saudáveis do ponto de vista cognitivo, observou que a alta adesão a dieta do mediterrâneo estava associada a menor risco de desenvolver TNL e a menor taxa de conversão de TNL para DA.

É aquela composta por sementes, peixe, verduras, frango, evitar carne vermelha e é uma dieta pobre em carboidratos.

- **Reabilitação cognitiva:** tem melhora significativa da função cognitiva global.

▼ **Farmacológico**

O uso de medicações para alzheimer e outras doenças foi testado, mas observou-se que a melhora da memória foi mínima, tendo mais efeitos colaterais do que benefícios.

Estudo com Donepezil x Placebo por 48 meses, 2037 idosos, houve pequena melhora cognitiva medido pela escala ADAS-COG. (Doody et al., 2007)

O tratamento não reduz a incidência de Demência a longo prazo.

A memantina não deve ser usada para tratamento do TNL. Evitar usar medicamentos anticolinérgicos, bzd e paroxetina.

Doença de Alzheimer

▼ **Epidemiologia**

Pessoas com demência em todo o mundo mais que dobrou, de 20.2 milhões, em 1990, para 43.8 milhões, em 2016. Cerca de 1 a cada 5 >65 anos tem DA nos EUA.

Nos EUA, a DA representa aproximadamente 60% a 70% dos casos de demência, e dobra cada 5 anos depois dos 60 anos.

2:1 feminino/masculino.

O início precoce da DA (<60 anos de idade) é frequentemente hereditário, com padrão autossômico dominante, e representa <1% dos casos.

Obs: a doença de Alzheimer foi descoberta pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer, que diagnosticou nessa paciente, chamada Augusta D, um quadro de alterações de memória e confusão mental.

▼ Fatores de risco

- Baixa escolaridade;
- Baixa audição;
- Dislipidemia;
- Depressão;
- TCE;
- Sedentarismo;
- DM;
- HAS;
- Tabagismo;
- Obesidade;
- Uso excessivo de álcool;
- Isolamento social;
- Poluição atmosférica;
- Déficits visuais.

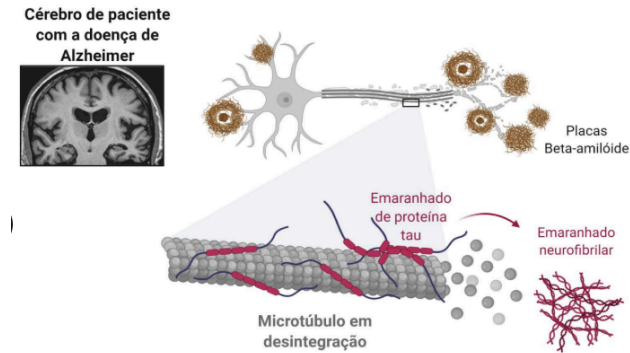
Não modificáveis: envelhecimento, gênero feminino, história familiar positiva, Down (mais placas senis do que outros pacientes) e presença do ALELO E4.

Presença de **mutações** podem causar DA precoce: gene da proteína precursora amiloide APP (cromossomo 21), gene da presenilina 1(cromossomo 14) e PSEN 2 (cromossomo 1). Cromossomo 12 pode causar DA tardio, mas é controverso.

▼ Fatores protetores

São fatores protetores e postergadores da doença: atividade física, dieta do mediterrâneo, alta escolaridade e atividade intelectual.

▼ Fisiopatologia



A proteína precursora amiloide (PPA) é que leva a formação da proteína beta amiloide. A PPA está envolvida na plasticidade neuronal e na formação das sinapses.

Fisiologicamente a PPA é clivada em situações fisiológicas pela alfa secretases.

Na doença de Alzheimer a PPA é **clivada de maneira anormal** pelas enzimas betasecretases e gama secretases, formando mais **beta amiloides extracelulares** que causam um processo inflamatório e lesam o neurônio, processo que começa no bulbo olfativo.

Além disso, ocorre uma **hiperfosforilação da proteína TAU** (responsável pelo citoesqueleto), levando a uma distrofia e edema dos microtúbulos, formando os emaranhados neurofibrilares que ficam no citoplasma, levando a uma **lesão intracelular** e morte neuronal.

Além da alteração microscópica, temos atrofias em lobos frontais, temporais e parietais, com redução de acetilcolina e serotonina e excesso de glutamato, contribuindo para as queixas cognitivas e neuropsiquiátricas.

Obs: a região do hipocampo e o córtex entorrinal, que é a primeira lesão, é o primeiro local onde começa a aparecer a doença de Alzheimer no cérebro.

▼ Quadro clínico

São sinais de alerta para DA:

- Perda de memória: especialmente recente;
- Dificuldade na execução de tarefas cotidianas;
- Problemas de linguagem;
- Prejuízo de julgamento;
- Dificuldade em tarefas abstratas;

- Perda de objetos;
- Mudança de personalidade;
- Perda de iniciativa: mais apáticos, desatentos.

O **sintoma de apresentação** geralmente é a perda da memória recente, e frequentemente dificuldade com as funções executivas e/ou disfasia nominal (dificuldade em encontrar palavras e nomes).

Não lembrar de nomes de visitantes recentes, repetição de assuntos, confusos em usar as medicações e vir nas consultas.

▼ Fase leve

- Diminuição da memória episódica. Inclusive o paciente tem dificuldade de reconhecer seu próprio déficit, chamamos de anosognosia;
- Dificuldade em recordar datas, compromissos, nomes de parentes;
- Dificuldade em reconhecer seu déficit de memória;
- Dificuldade em encontrar palavras e de aprender fatos novos;
- Perda de objetos;
- Deixam alimentos queimarem;
- Desorientação no tempo e espaço;
- Dificuldade em reconhecer faces e pode se perder em caminhos familiares;
- Desatenção, perda da iniciativa, retraimento social: paciente para de sair e se envolver com as coisas que ele se envolvia antes;
- Mudanças no humor depressão, apatia, irritabilidade, raiva, ansiedade: principalmente porque se irritam que não conseguem lembrar as coisas;
- Raramente temos ideias delirantes: paranoia, delírio de ciúmes, erros de identificação.

▼ Fase moderada

- Perda mais acentuada da memória: comprometimento até de coisas mais antigas;
- Aparecimento de apraxia ideatória (não lembra a sequência correta dos movimentos, por exemplo coloca o sapato e depois coloca a meia) e

ideomotora (pedimos para fazer um comando motor e a pessoa não lembra como faz), agnosia;

- Empobrecimento do vocabulário, dificuldade de compreensão, dificuldade de nomeação, circunlóquios (dar voltas e usar palavras excessivas para explicar uma ideia simples);
- Dificuldade de tarefas complexas;
- Dificuldade em fazer cálculos, traçar objetivos;
- Dificuldade em realizar as atividades de vida diária;
- Aparecimento de sintomas extrapiramidais: rigidez, lentificação;
- Aparecimento dos sintomas neuropsiquiátricos.

Apatia, delírios, alucinações, alterações do ciclo sono- vigília, paranóias, agressividade, reações catastróficas, erros de identificação, depressão.

- Síndrome do sol poente: aumento de agitação, confusão, ansiedade e desorientação no final da tarde, ao anoitecer ou durante a noite;
- Síndrome de Othelo: acha que o companheiro está traindo;
- Síndrome de Godot: paciente vê um familiar mas acha que é outra pessoa;
- Delírio de Roubo;
- Sinal do Espelho: não se reconhece no espelho;
- Hóspedes Fantasmas: acha que tem gente estranha na casa, ladrão, pessoas que morreram;
- Síndrome de Diógenes: mais rara, paciente quer viver na pobreza.

▼ Fase grave

Todas as funções cognitivas são afetadas. Pacientes são totalmente dependentes nas atividades de vida diária, não consegue mais obedecer a comando simples, como se sentar ou se levantar.

- Todas as funções cognitivas afetadas;
- Pacientes totalmente dependentes para AVDS;
- Dificuldade de falar sentenças completas e obedecer a comandos simples;
- Ecolalias (repete o que fala a ele), palavras inarticuladas, mutismo (não fala);

- Incontinência urinária e fecal (podem começar na moderada também);
- Disfagias;
- Morte por imobilismo.

Resumindo:

	CCL	Leve	Moderada	Severa
Memória	Amnésia	Amnésia	Amnésia e alteração de memória remora	Ausente
Linguagem	Normal	Redução da fluência verbal	Anomia	Afasia
Habilidade visuoespacial	Normal	Levemente anormal	Moderadamente anormal	Severamente anormal
Função executiva	Minimamente afetada	Levemente anormal	Moderadamente anormal	Não testável
AVDs	Não afetadas	Comprometimento das AVDs	Comprometimento das AVDs	Totalmente dependente

▼ Diagnóstico

▼ Testes de avaliação cognitiva

1. Moca Teste
2. MEEM
3. 10-CS
4. Teste do relógio
5. Memória de Lista de palavras
6. Memória de Figuras
7. Fluência verbal.

Exame Neuropsicológico: quadros duvidosos, especialmente em quadros leves.

▼ Exames laboratoriais

HMG completo, uréia, creatinina, albumina, glicemia jejum, TSH, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico, TGO, TGP, cálcio sérico, sorologia para sífilis (VDRL, FTAb), HIV.

▼ Liquor

Dosagem de proteína beta-amiloide e proteína tau no liquor, sensibilidade 85 a 90%, com aumento da proteína TAU e redução da beta-amiloide.

▼ Biomarcadores

Há varios biomarcadores sanguíneos em estudo. Devem ser usados para aqueles que tem evidencia de alteração cognitiva nos testes, exames de imagem.

PrecivityAD2: taxa de acerto 90%. Melhor usar em fase leve, que não temos tanta certeza do diagnostico.

▼ Exame de imagem:

- TC de Crânio: excluir outras causas;
- RNM de Encéfalo: melhor, evidencia atrofia desproporcional na RNM, nos lobos temporais medial, basal e lateral e no córtex parietal medial.;
- SPECT cerebral: hipoperfusão temporoparietal bilateral;
- PET FDG: hipometabolismo em córtex cingulado posterior e córtex temporoparietal;
- PET amiloide: depósito de B-amiloide, positiva precocemente;
- PET TAU: detecta depósito de proteína TAU, correlaciona-se com a gravidade clínica.

▼ Tratamento

▼ Tratamento não farmacológico

- Terapia ocupacional: terapia de reminiscências, atividades como caminhadas, pinturas, crochês, lazer;
- Afeto e apoio familiar;
- Cuidado com o estresse do cuidador;
- Musicoterapia;
- Evitar a quebra inesperada da rotina;
- Fisioterapia Motora;
- Nutrição.

▼ Tratamento farmacológico

▼ Anticolinesterásicos

- **Rivastigmina** (1,5 a 6,0mg): inibição da acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Tem via oral e adesivo;

- **Galantamina** (8mg, 16mg e 24mg): inibição da acetilcolinesterase e agonista do receptor nicotínico;
- **Donepezila** (5 e 10Mg): inibição da acetilcolinesterase.

Eficácia dos inibidores: é semelhante entre eles, sem uma superioridade individual.

Obs: incremento de doses é cada 4 a 6 semanas, sempre chegar em doses teto. Mas não começamos com a dose maior.

Benefícios são modestos com **melhora temporária** dos sintomas e retardo do declínio por 6 a 12 meses, podendo chegar a 24 a 36 meses.

Atua na cognição, mas principalmente comportamento e funcionalidade, diminui a sobrecarga do cuidador, desacelera a doença, causa redução do número de antipsicóticos. Devemos deixar o paciente, cuidador e familiares cientes disso.

Vias de eliminação:

- Galantamina: rins e fígado;
- Rivastigmina: rins. Tem menos interação com o P450;
- Donepezil: fígado. Melhor usar em pacientes com distúrbio renal.

Se o **paciente deteriora rapidamente** e de forma inesperada, mesmo recebendo tratamento, devemos **procurar causas**, analisar comorbidades, uso de medicações, delirium, causas comportamentais.

Efeitos colaterais:

- Gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia e anorexia, dor abdominal. Suspende a medicação e trocar por outra ou reduzir a dose, recomendar tomar com o estomago cheio;
- Cardiovasculares: oscilação da PA, síncope, arritmias, bradicardia. BAV, bradicardia sinusal devemos cuidar ao usar a medicação pois o paciente pode fazer síncope;
- Neurológicas: tonturas, cefaléia, confusão mental, agitação, sonolência e insônia;
- Outros: sudorese, fadiga, perda de peso, câimbras e aumento da secreção brônquica (DPOC grave não tem indicação de usar).

Quando devemos **descontinuar ou trocar** o anticolinesterásico:

- Quando o paciente adere mal ao tratamento;
- Se a deterioração cognitiva se mantém no mesmo ritmo prévio, após 3 a 6 meses de tratamento;
- Quando há uma rápida deterioração, após um período inicial de estabilização;
- Fase avançada da doença com imobilismo.

40 a 50% dos pacientes não respondem aos anticolinesterásicos.

▼ **Memantina**

Permite a ativação fisiológica dos receptores N-Metil-D-Aspartato, que se contrapõem a ação do glutamato nestes receptores.

Indicação na **fase moderada e grave**.

Doses 10 até 20mg/dia.

Eliminação é renal.

Efeitos colaterais: alucinações, confusão mental, tonturas, cefaleia, diarreia, insônia, agitação e fadiga.

Obs: Lacanemab e Donanemab são medicações liberadas pela anvisa como alternativa, mas apesar de reduzir a proteína beta amiloide, o distúrbio cognitivo não teve melhora, e tiveram como efeitos colaterais edema e hemorragia cerebral, por isso não pode ser indicada em paciente com uso de anticoagulante/antiagregante. É uma medicação cara e deve ser acompanhada mensalmente com exame de imagem.

▼ **Outros**

Em quadro Neuropsiquiátrico:

- Antidepressivos: delírios, alucinações, depressão;
- Neurolépticos atípicos: principalmente naqueles pacientes que são agressivos;
- Estabilizadores do humor: principalmente naqueles pacientes que são agressivos.

Demências de corpos de Lewy

▼ **Definição**

É uma síndrome neuropsiquiátrica degenerativa primária, caracterizada clinicamente por sintomas cognitivos, motores, psiquiátricos e autonômicos.

Está incluída no grupo das sinucleinopatias, do qual fazem parte a doença de Parkinson idiopática sem e com demência, a atrofia de múltiplos sistemas, a neurodegeneração associada à pantotenatoquinase (previamente denominada síndrome de Hallervorden-Spatz) e a distrofia neuroaxonal.

▼ Epidemiologia

Segunda causa mais comum de demência degenerativa, perdendo apenas para doença de Alzheimer, presente em 20-30% dos casos em séries de necropsias.

Corresponde a 3,2-7,1% de todas as demências.

Mais prevalente em homens, com 36% com componente genético.

Mais prevalente com 75-80 anos.

▼ Fisiopatologia

A demência por corpos de Lewy (DCL) é uma **alfassinucleinopatia**, grupo de doenças caracterizadas pelo acúmulo patológico da proteína α -sinucleína

A α -sinucleína é uma proteína normalmente presente nos terminais pré-sinápticos dos neurônios, onde participa da regulação da liberação de neurotransmissores. Em condições patológicas, essa proteína sofre misfolding (dobramento anormal) e passa a formar agregados insolúveis, que se acumulam no interior das células nervosas, originando os corpos de Lewy.

A distribuição desses depósitos determina as manifestações clínicas das diferentes sinucleinopatias:

- Doença de Parkinson: os corpos de Lewy se acumulam predominantemente no tronco encefálico, especialmente na substância negra, levando à degeneração dos neurônios dopaminérgicos e predominância de sintomas motores;
- Demência por Corpos de Lewy: os depósitos de α -sinucleína ocorrem de forma mais difusa, envolvendo córtex cerebral e estruturas subcorticais, o que resulta em comprometimento cognitivo precoce, além de sintomas motores e neuropsiquiátricos;
- Atrofia de Múltiplos Sistemas: acúmulo de α -sinucleína ocorre predominantemente em oligodendrócitos, formando as chamadas inclusões citoplasmáticas gliais (corpos de Papp-Lantos).

Estudos neuropatológicos sugerem que os depósitos de α -sinucleína **podem iniciar em estruturas como o bulbo olfatório e o núcleo motor dorsal do nervo vago**, o que explica sintomas precoces como hiposmia e disfunção autonômica.

Além disso, **ocorre degeneração dopaminérgica**, semelhante ao observado na doença de Parkinson, contribuindo para os sintomas parkinsonianos.

A **DCL também apresenta déficit colinérgico importante**, geralmente mais intenso que na Doença de Alzheimer. Essa disfunção colinérgica cortical, especialmente envolvendo receptores muscarínicos M1, está relacionada à ocorrência de alucinações visuais e flutuações cognitivas, características marcantes da doença.

▼ **Quadro clínico**

As manifestações clínicas na DCL incluem, além do comprometimento cognitivo, sintomas psiquiátricos (alucinações, alterações de comportamento, depressão, apatia, ansiedade), neurológicos (parkinsonismo, transtornos do sono, falência autonômica) e clínicos (síncope, hipotensão postural, quedas, incontinência urinária, constipação intestinal).

O padrão de déficits neuropsicológicos da DCL difere do encontrado na demência na doença de Alzheimer, com declínio de memória menos marcante e déficits mais graves de atenção e de funções visuais espaciais, frontais e executivas.

A maioria dos casos ocorre em idades mais avançadas, com duração média da doença variando de 6 a 10 anos. A velocidade de progressão dos sintomas é geralmente mais rápida do que na demência na doença de Alzheimer.

▼ **Comprometimento cognitivo**

É o sintoma mais precoce na maioria dos pacientes com DCL, sendo, em geral, de instalação insidiosa, com quadros flutuantes.

Em muitos casos, a apresentação clínica é caracterizada por episódios recorrentes de confusão mental sobre os quais se sobrepõe quadro de deterioração cognitiva progressiva.

Os pacientes exibem uma combinação de alteração:

- **Corticais:** memória, linguagem, funções executivas e visuoespaciais.
Podemos avaliar pela fluência verbal e o teste do relógio, que ambos estarão alterados.
- **Subcorticais:** atenção, velocidade de pensamento, praxia visual contrutiva.
Podemos avaliar pelos pentágonos, paciente não consegue desenhar.

Nas fases iniciais da doença, no entanto, os déficits de memória são leves, e a linguagem encontra-se preservada (exceto por redução da fluência verbal), sendo mais acometidas as funções relacionadas com a atividade subcortical, com déficits mais pronunciados de atenção, de habilidades visuais espaciais, da velocidade de processamento cognitivo e da capacidade de resolução de problema.

▼ Flutuações

As flutuações podem variar em **dias, horas e minutos, 75% dos pacientes terão flutuações importantes.**

Os pacientes apresentam períodos espontâneos de redução do estado de alerta e da concentração, ficam pouco interativos com o ambiente, podendo aparentar sonolência.

Os paciente perdem a capacidade de realizar atividades, mas em um momento sabem fazer tudo em outro esquecem até de tomar banho, a cognição altera até 50% de um dia para o outro.

▼ Alucinações visuais

Podem ser iniciais ou tardias. São vividas, recorrentes, bem estruturadas, tridimensionais e detalhadas, com objetos e pessoas.

Sempre que tiver alucinações no idoso devemos pensar no quadro demencial e no delirium. Pode ter alucinações que os objetos tem vida, como colher conversando com ele, cadeira conversando.

Pode ter alucinações auditivas também, apesar de menos comum.

As alucinações visuais na DCL podem persistir por meses, ou até anos, e podem se agravar, tornando-se de cunho ameaçador e sem o discernimento da realidade.

▼ Transtorno comportamental do sono REM

É uma parassonia em que ocorre **ausência da atonia musculoesquelética**, normalmente observada durante o sono REM, associada à atividade motora proeminente, com movimentos repetitivos do tronco e dos membros, e com vocalizações, além de sonhos vívidos e assustadores, em geral envolvendo insetos, animais ou seres humanos.

É uma alteração comum nas alfasinucleinopatias, em **até 93% dos pacientes.**

Dentre outros transtornos do sono evidentes nessas demências, incluem-se sonolência diurna excessiva, movimentos periódicos noturnos dos membros, confusão ao despertar e pesadelos.

Tais alterações podem preceder em muitos anos o diagnóstico de DCL, por comprometimento da formação reticular bulbar, cujos neurotransmissores são a norepinefrina e a acetilcolina, já nos primeiros estágios da doença.

Atualmente é considerado como um dos critérios clínicos centrais para o diagnóstico de DCL.

▼ **Parkinsonismo**

O parkinsonismo está presente em 75% dos pacientes, mas nos estágios iniciais, pode estar ausente em até 50% dos casos.

A síndrome parkinsoniana é, em geral, de tipo **rígido-acinético e com predomínio axial, bilateral, e simétrico** causando instabilidade postural, alteração de marcha, bradicinesia e hipomímia facial, além de mioclonias, disartria e hipofonia.

Tremor é um achado pouco comum e, quando presente, costuma ser de leve intensidade.

Se temos sintomas de Parkinson se apresentam simultaneamente ou depois dos sintomas cognitivos é característico de demência de corpos de Lewy.

Tem resposta menor ou ausente a levodopa, diferindo da doença de Parkinson.

▼ **Hipersensibilidade aos antipsicóticos**

Ocorre piora motora rápida, a acentuação do declínio cognitivo e o desenvolvimento de síndrome neuroléptica maligna e a morte.

Cerca de 30 a 50% dos pacientes com DCL apresentam sensibilidade grave a esses fármacos.

Por isso, esse dado é considerado como critério de apoio ao diagnóstico e tornou-se relevante no manejo farmacológico dos pacientes com DCL.

Obs: se for preciso usar, devem ser os atípicos e em doses muito muito baixas.

▼ **Disfunção autonômica**

As manifestações clínicas decorrentes são:

- Instabilidade postural;
- Quedas de repetição;

- Hipotensão ortostática;
- Hipersensibilidade de seio carotídeo: pode ter hipotensão apenas por palpar pulso carotídeo;
- Episódios sincopais e pré-sincopais;
- Constipação intestinal;
- Incontinência urinária.

▼ Outras manifestações psiquiátricas

- Depressão;
- Delírios: conteúdo complexo e bizarro;
- Síndrome de Capgras/delírio de substituição: familiares ou cuidadores são tidos como impostores, imagens da TV são interpretadas com realidade ou a do próprio paciente no espelho é tida como imagem de outra pessoa;
- Alucinações auditivas, olfatórias e táteis;
- Ideação delirante: presença de estranhos ou intrusos em casa ou a crença de que familiares ou amigos falecidos estão visitando.

▼ Diagnóstico

▼ Critérios

Critério obrigatório: demência, ou seja, declínio cognitivo progressivo suficiente para interferir nas atividades sociais e ocupacionais ou atividades diárias.

Características centrais:

- Flutuação congitiva;
- Alucinações visuais;
- Transtorno comportamental do sono REM;
- Parkinsonismo: ≥ 1 sinais cardinais de parkinsonismo como bradicinesia (definido com lentidão de movimentos e decréscimo de amplitude ou velocidade), tremor de repouso ou rigidez.

Características de suporte:

- Hipersensibilidade grave aos antipsicóticos;
- Instabilidade postural;

- Quedas;
- Hipersonia;
- Hiposmia;
- Alucinações não visuais e delírios;
- Apatia, ansiedade e depressão.

Biomarcadores indicativos:

- Redução na captação e transporte de dopamina nos núcleos da base demonstrados por SPECT e PET;
- Baixa captação de MIBG por cintilografia miocárdica indicando uma deservação simpática;
- Confirmação polissonográfica de sono REM sem atonia.

Biomarcadores de suporte:

- Relativa preservação das estruturas do córtex temporal medial à RM e TC;
- Hipoperfusão/hipometabolismo occipital no SPECT/PET +/- "sinal da ilha do cíngulo" no PET-FDG;
- Atividade posterior proeminentemente lenta no EEG, com flutuações periódicas do intervalo teta-alfa.

Diagnóstico provável:

- ≥ 2 características centrais, independente de biomarcadores;
- 1 característica central + ≥ 1 biomarcadores.

Diagnóstico possível:

- 1 característica central + ausência de biomarcadores indicativos;
- ≥ 1 biomarcador indicativo + ausência de critérios clínicos centrais.

II. Critério obrigatório
1. Declínio cognitivo progressivo suficiente para interferir nas atividades sociais e ocupacionais ou atividades diárias:
a. Déficit proeminente em testes de atenção, habilidades visuais-espaciais e funções frontais subcorticais
b. Comprometimento da memória pode não ocorrer nos estágios iniciais, mas é evidente com a progressão
III. Características clínicas centrais (os três primeiros tipicamente ocorrem desde o início)
1. Flutuação na cognição com pronunciadas variações na atenção e no estado de alerta
2. Alucinações visuais recorrentes tipicamente bem formadas e detalhadas
3. Transtorno comportamental do sono REM (pode preceder o declínio cognitivo)
4. Um ou mais sinais cardinais de parkinsonismo: bradicinesia (definido com lentidão de movimentos e decréscimo de amplitude ou velocidade), tremor de repouso ou rigidez
IV. Características clínicas de suporte (que apoiam o diagnóstico):
1. Hipersensibilidade grave aos antipsicóticos
2. Instabilidade postural
3. Quedas de repetição, síncope ou outros episódios transitórios de disfunção autonômica grave (p. ex., constipação intestinal, hipotensão ortostática, incontinência urinária)
4. Hipersonia
5. Hiposmia
6. Alucinações de outras modalidades, delírios estruturados
7. Apatia, ansiedade e depressão
V. Biomarcadores indicativos
1. Redução na captação e transporte de dopamina nos núcleos da base demonstrados por SPECT e PET
2. Captação anormal (baixa) de MIBG por cintilografia miocárdica
3. Confirmação polissonográfica de sono REM sem atonia

▼ Tratamento

O tratamento da DCL é particularmente difícil em função da coexistência de sintomas cognitivos, psiquiátricos e parkinsonianos. Com múltiplos transmissores afetados ao mesmo tempo.

▼ Medidas não farmacológicas "o mínimo"

É educação sobre a doença, sintomas e riscos.

▼ Tratamento farmacológico

Individualizado para cada sintoma, preparar para os colaterais.

Focar no sintoma principal a cada momento e reavaliar frequentemente.

- Antiparkinsonianos: baixa resposta, podem precipitar alucinações e delírios;
- Antipsicóticos: podemos usar quetiapina e clozapina, por conta da hipersensibilidade e pode induzir ou piorar parkinsonismo;

Obs: clozapina é preciso hemograma freqente pelo risco de agranulocitose, então usamos mais quetiapina mas em dose muito baixa (quebra o

comprimido de 25 mg) e avaliar.

- Anticolinesterásicos: eventos cardiovasculares, piora do tremor, efeito gastrointestinal, quedas e maior instabilidade postural.

Melhora comportamental e cognitiva em testes, mas leve e questionável com revisões divergentes. A memantina não tem benefícios, é um antagonista da MNDA.

- Antidepressivo e estabilizadores do humor: na prática não tão bons.

Se for usar antidepressivos para controle comportamental, apatia, usamos principalmente Trazodona em dose mais hipnótica do que antidepressivo, como 25-100 mg.

Demência associada à doença Parkinson

▼ Definição

Sintomas motores e o diagnóstico da doença de Parkinson precedem os sintomas cognitivos em pelo menos 1 ano. Ou seja, parkinsonismo ≥ 12 meses antes da demência.

▼ Epidemiologia

A prevalência da DDP varia de 26 a 44% e ocorre em fases mais tardias da doença, chegando a afetar cerca de 80% dos casos de doença de Parkinson após 8 anos de evolução

▼ Fatores de risco

Os principais fatores de risco já identificados para o desenvolvimento de demência na doença de Parkinson:

- Idade avançada;
- Início tardio da doença de Parkinson;
- Funções cognitivas já comprometidas à avaliação inicial, incluindo a presença de comprometimento cognitivo leve;
- Progressão rápida da doença com predomínio de sintomas rígido-acinéticos;
- Má resposta à levodopa desde o início do tratamento;
- Presença precoce de alucinações;
- Formas não tremulantes da doença;

- Maior gravidade de comprometimento motor.

▼ Quadro clínico

As alterações motoras são as específicas da doença de Parkinson:

- Rigidez;
- Bradicinesia;
- Tremor de repouso;
- Reflexos posturais alterados;
- Início assimétrico;
- Marcha parkinsoniana;
- Boa resposta à terapia com levodopa.

No que diz respeito ao comprometimento cognitivo progressivo, assim como na DCL, a DDP caracteriza-se pelo acometimento mais frequente das funções executivas, da atenção e das habilidades visuais-espaciais.

As alterações de memória, orientação e linguagem vão surgindo de forma mais intensa à medida que a doença progride.

As alucinações visuais e flutuações cognitivas são menos comuns do que na DCL, ao passo que déficits de atenção auditiva e visual são mais frequentes.

▼ Diagnóstico

■ **TABELA 18.5** Diagnóstico de demência associada à doença de Parkinson (DDP) conforme critérios propostos pela Sociedade de Transtornos do Movimento (MDS Task Force).

1. Diagnóstico de DDP com base no critério do Banco de Cérebros de Londres (*Queen's Square Brain Bank Criteria*)
2. Doença de Parkinson estabelecida previamente ao início dos sintomas demenciais
3. Redução global da cognição (MEEM < 26 pontos)
4. Comprometimento cognitivo grave o bastante para prejudicar as atividades diárias (confirmado pelos familiares e cuidadores)
5. Prejuízo em pelo menos dois dos seguintes domínios da cognição:
 - a. Atenção
 - b. Funções executivas
 - c. Habilidades visuais-construtivas
 - d. Memória

A cintilografia MIBG cardíaca que avalia a inervação simpática cardíaca pós ganglionar possui índice coração/mediastino reduzido na DDP e DCL.

O TRODAT/SPECT que cria uma imagem de transportador dopaminérgico pré-sináptico está reduzido em DCL e DDP mas normal em DA.

▼ Tratamento

O tratamento farmacológico da DDP inclui, além da levodopa e, eventualmente, outros agentes dopaminérgicos, o emprego de inibidores da colinesterase e da memantina.

A Rivastigmina é o medicamento de melhor evidência para tratamento cognitivo na DDP e DCL.

Característica	DCL	DDP	DA
Sequência temporal	Cognição > Motricidade	Motricidade precede cognição ≥12 meses	Só cognição, motor tardio
Perfil cognitivo	Executivo + visuoespacial, memória relativamente preservada	Subcortical frontal, memória preservada inicialmente	Memória episódica proeminente
Alucinações visuais	Precoces, preeminentes em 60-80%	Presente em 40-50%	Tardias, raras no início
Flutuação cognitiva	Marcante, característico	Pode ocorrer	Ausente ou discreta
DCSREM	Frequente, em 80%	Frequente	Raro
DAT-SPECT	Reduzido	Reduzido	Normal ou discretamente reduzido
MIDG cardíaco	Reduzido	Reduzido	Normal
Resposta a levodopa	Moderado	Boa inicialmente	N/A

Comprometimento cognitivo vascular e demência vascular

▼ Definição

Definido como **comprometimento cognitivo resultante de eventos cerebrovasculares**.

Primeiras descrições em 1549. Alôis Alzheimer e Otto Binswanger descreveram quatro tipos diferentes (Séc XIX):

- Degeneração cerebral arteriosclerótica (demência por múltiplos infartos);
- Gliose perivascular do córtex cerebral ou atrofia cortical senil (atrofia granular e necrose laminar);
- Demência pós-apoplexia (demência lacunar);
- Encefalite subcortical progressiva crônica (doença de Binswanger).

O termo comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é usado para definir um estágio intermediário do declínio cognitivo preditivo de demência degenerativa e predominantemente ligado ao comprometimento da memória. O termo Comprometimento Cognitivo Vascular (CCVa) foi instituído por Hachinski e é dividido em:

- **Comprometimento Cognitivo Vascular (CCVa):** um declínio cognitivo sem levar a prejuízo nas AVDs, tanto as básicas como as instrumentais. Podem apresentar dificuldade em tarefas complexas;
- **Demência vascular (DVa):** comprometimento cognitivo que afeta as AVDs.

▼ Epidemiologia

Prevalência da demência vascular de 3-6% nos idosos, pode representar de 10-50% de todos os casos de demência. Post mortem 10-20% são demência por múltiplos infartos + 10-20% com Alzheimer associado a componente vascular.

A epidemiologia varia devido à falta de critérios diagnósticos claros e universais, e existência de quadros mistos (vascular+alzheimer).

▼ Fisiopatologia

Infartos causando morte neuronal, variando conforme a localização, número de infartos, fatores não identificados.

Doença arterial de pequenos vasos é a mais comum em idosos, pois a fibrose deixa os vasos mais rígidos, reduzindo a microcirculação, sendo acentuado pela HAS e DM.

Ocorre interrupção de circuitos neuronais que ligam o córtex frontal à outras áreas, como mesencéfalo, causando 3 síndromes possíveis:

- Dorsolateral: disfunção executiva + evocação;
- Orbitofrontal: distúrbio comportamental + emoção;
- Cingulada anterior: abulia, mutismo acinético.

Com o envelhecimento fisiológico ocorre deposição de placas senis e emaranhados neurofibrilares, além das lesões vasculares pequenas, que são silenciosas, progridem causando redução da capacidade cognitiva de reserva. Quanto maior a reserva cognitiva, menor o risco de demência vascular, pois quanto maior a cognição, mais lesão é preciso para chegar em um ponto que cause comprometimento.

Lesões que causam déficit cognitivo:

- **Atrofia cerebral:** presente na maioria das demências, sem evidência de nível relacionada ao CCVa, ou seja, não tem relação com menor cérebro maior declínio cognitivo;
- **Lesões de substância branca:** seja difusas ou focais. A lesão vascular estará mais presentes em regiões profundas dos hemisférios, onde há mais vasos perfurantes, também na área periventricular, em que o líquido acaba pressionando mais os vasos, sendo mais sensível;
- **Hipótese da desconexão:** perda da conexão córtico-subcortical, ou seja, parte mais alta do cérebro perde a conexão com a parte mais baixa, reduzindo também a mielina e reduzindo a velocidade de condução, aumentando o tempo para ter o ideal cognitivo.

▼ Etiologia

- **Infartos múltiplos em vasos de grande calibre:** AVC, dependendo do local que acomete, pode causar diferentes sintomas;
- **Infartos lacunares múltiplos:** AITs, local que ocorre isquemia temporária, causando sequelas mas não a ponto de causar um déficit muito importante;
- **Infarto único em localização estratégica:** restrita, poucos infartos em regiões cerebrais subcorticais funcionalmente importantes (tálamo, gânglios basais, territórios das artérias cerebrais anterior e média, giro angular);
- **Hipodensidades subcorticais (leucoraiose) e demência do tipo Biswanger:** ocorrem mais na HAS, levando a lesão da microcirculação e micro-hemorragias, mas é mais raro no dia-dia;

A demência do tipo Biswanger é marcada por infartos lacunares, em geral, medindo de 5 a 10 mm de diâmetro, com amplo e predominante comprometimento da substância branca.

- **Hemorragias cerebrais hipertensivas;**

- **Sequelas de hemorragia subaracnóidea e de hematomas subdurais;**
- **Angiopatia cerebral congófila** (amiloide): cora com vermelho do congo para fazer diagnóstico, causa microhemorragias podendo identificar depósito de hemociderina na RNM;
- **Vasculites inflamatórias, Infecciosas e tóxicas;**
- **Síndrome dos anticorpos anticardiolipinas;**
- **Hipoperfusão global grave;**
- **Angiopatias hereditárias:** como Cadasil (arteriopatia autossômica dominante).
Associa-se a uma degeneração progressiva das células musculares lisas e ao acúmulo de depósitos granulares osmiofílicos na lâmina basal de pequenas artérias

▼ Fatores de risco

▼ Não modificáveis

- Sexo masculino;
- Idade: quanto maior idade, maior o risco acumulado. O risco dobra a cada 5-10 anos após os 65 anos;
- Predisposição genética: CADASIL, angiopatia amiloide;
- Etnia: russos e japoneses;
- AVE prévio: presente em 76% na DVA e 57% no CCVa, contra apenas 5-7% nas DA.

▼ Modificáveis

- **Baixo nível intelectual:** pois isso, maior nível socioeconômico, menor demência;
- **Hábitos de vida:**
 - Consumo limitado de álcool: quanto mais álcool maior o risco de demências;
 - Tabagismo: risco aumentando de DA e principalmente DVa;
 - Atividade física: fator protetor, então pacientes sedentários tem mais riscos;
 - Nutrição: dieta equilibrada (mediterrâneo) e rica em Omega3.

- **Comorbidades:**

- Dislipidemia: relação direta maior ocorrência de DA e DVA;
- HAS: evidência conflitante, mas reduz doença cardiovascular;
- FA: incorreu em um risco maior de demência e mortalidade especialmente pelo risco de desenvolver IC, contribuindo para redução da perfusão cerebral;
- Doença cerebrovascular (AVE): inquestionável, aumenta muito o risco de demência;
- Síndrome de resistência insulínica e DM: aumento da DCV com aumento dos casos de demência.

▼ **Diagnóstico**

Mais comumente afeta a cognição nos sistemas frontobasais, afetando julgamento, planejamento, emoção.

A clínica pode variar a depender do local da lesão/etiologia. Por exemplo:

- Infartos de grandes vasos corticais: podem causar afasia, apraxia, amnésia;
- Infartos subcorticais e lacunares: podem causar déficits mais sutis e progressivos.

Como ocorre desconexão córtico-subcortical, há maior sintomatologia na parte executiva, afetando a velocidade de processamento + planejamento, atenção e monitoramento.

O teste MOCA é o mais alterado, tendo dificuldade em nomear, bater na mesa, desenhar o cubo.

Memória pode estar prejudicada, mas consegue se utilizar de pistas para responder as perguntas, difere do alzheimer pois com algumas dicas o paciente com DV pode relembrar palavras, por exemplo. Sintomas comportamentais e psicológicos presentes, labilidade emocional muito comum.

▼ **Achados neuropsicológicos**

- **Depressão:** sintoma mais comum, podem não ser tão aparentes quanto a depressão clássica, é mais resistente aos medicamentos;
- Labilidade emocional: uma hora feliz, uma hora chorando;
- **Apatia;**

- **Agressividade;**
- **Irritabilidade:** por atingir a região frontal, pode afetar o julgamento;
- Psicose: menos comum;
- Vagueamento: paciente muito quieto;
- Agitação/Inquietude.

▼ **Achados motores**

- Síndrome piramidal/síndrome do primeiro neurônio motor: motricidade voluntária;
- Síndrome extrapiramidais: motricidade involuntária, mais sensíveis ao Plasil;
- Marcha instável;
- Quedas frequentes;
- Síndrome pseudobulbar: presença da tríade de disartria, disfagia, labilidade emocional.

▼ **Achados radiológicos**

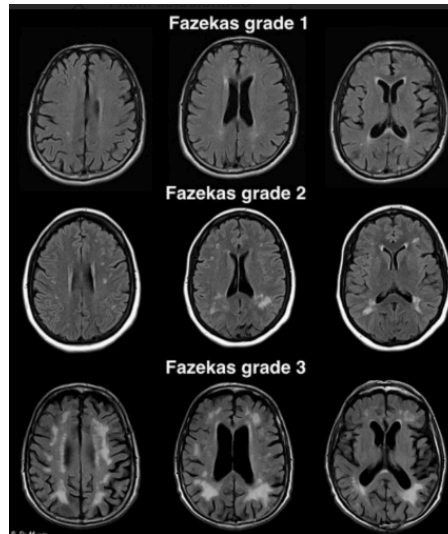
- **Leucoaraiose**

Hipodensidades subcorticais (TC) e Hipersinais em T2/FLAIR (RNM).

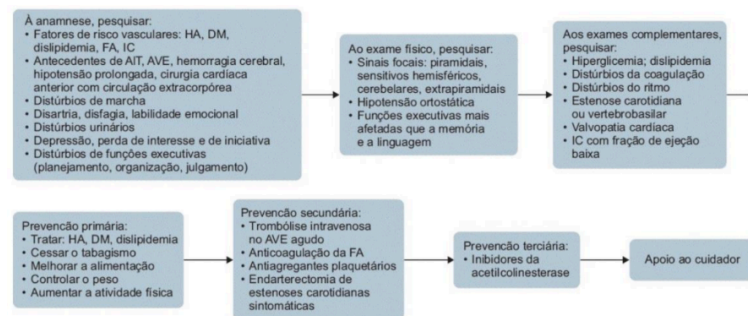
Achados na RM patológicos, classificados pelo FAZEKAS, podem ser:

- Hipersinais bem definidos, arredondados ou triangulares, nos cornos frontais e occipitais e imagens em pincel ao redor dos ventrículos laterais: é mais benigno;
- Lesões mais pronunciadas, com alterações na marcha, depressão, distúrbios urinários e cognitivos: mais patológicos.

Obs: FAZEKAS 2 >75 anos é considerado normal.



- Infartos silenciosos: infartos lacunares possuem maior associação, quanto maior a quantidade maior risco de declínio cognitivo e demência.



Há uma escala para tentar diferenciar a DV de alzheimer é a escala de Hachiski que analisa alguns sinais clínicos.

■ **TABELA 19.5** Escala isquêmica de Hachinski.

Característica	Pontuação
Início súbito	2
Deterioração em degraus	1
Evolução flutuante	2
Confusão noturna	1
Preservação relativa da personalidade	1
Depressão	1
Queixas somáticas	1
Instabilidade emocional	1
História de hipertensão arterial	1
Antecedentes de AVE	2
Evidência de aterosclerose associada	1
Sintomas neurológicos focais	2
Sinais neurológicos focais	2

Se ≥ 7 é muito sugestivo de demência vascular, 5-6 sugere mais demência mista e ≤ 4 doença de Alzheimer. Não é um critério diagnóstico, é para diagnosticarmos.

Os elementos críticos para o diagnóstico conceitual da DVa incluem:

- A síndrome cognitiva (tipo, extensão e combinação dos déficits nos diferentes domínios cognitivos);
- As causas vasculares estabelecidas (tipo de patologia nos vasos sanguíneos e dano cerebral resultante);
- A síndrome cognitiva da DVa é diferente da doença de Alzheimer: a disfunção executiva predomina sobre as alterações de memória e linguagem

▼ Critérios diagnósticos

▼ DSM-5

- Evidência de declínio cognitivo significativo a partir de um nível prévio de desempenho em ≥ 1 domínios cognitivos:
 - Aprendizagem e memória;
 - Função executiva;
 - Atenção complexa;
 - Motor-perceptivo;
 - Cognição social.

- Os déficits cognitivos interferem na independência das AVD e requerem, no mínimo, supervisão em atividades instrumentais complexas, como pagamento de contas ou manejo de medicamentos;
- Os déficits cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de um delirium;
- Os déficits cognitivos não são mais bem explicados por outro transtorno mental (transtorno depressivo maior, esquizofrenia);
- As características clínicas são consistentes com uma etiologia vascular, como sugerido por qualquer dos seguintes:
 - O início dos déficits cognitivos relaciona-se temporalmente a um ou mais eventos cerebrovasculares;
 - Evidência de declínio é proeminente na capacidade de atenção complexa (inclusive velocidade de processamento) e na função executiva frontal.
- Há evidência de DCV em história, exame físico e ou neuroimagem considerada suficiente para explicar os déficits cognitivos;
- Os déficits não são mais bem explicados por outra doença cerebral ou desordem sistêmica.

▼ Tratamento

Importante a educação, aconselhamento e apoio a pacientes, familiares e cuidadores, entendendo como é a doença.

Tratamento agressivo dos fatores de risco vasculares pode diminuir a progressão do comprometimento cognitivo.

- HAS: benefício incerto no desenvolvimento ou na piora de déficit cognitivo;
Meta análise: tratar a HAS trouxe diminuição no risco de AVE/IC/mortalidade geral.
- DM2: benefício incerto mesmo com controle intensivo (para demência);
Pode ser usado AAS como prevenção primária (nunca teve um AVC) em pacientes de alto risco com DM poderia ser benéfico (consenso de especialistas).
- Dislipidemia: sem benefício comprovado do tratamento com estatinas (para demência).

Obs: se não muda nada, por que fazer? pois em pacientes com DCV estabelecida, é recomendado tratar agressivamente os fatores de risco CV (DM, HAS, DSLP), mesmo que sem reduzir a progressão da doença, pode evitar um novo quadro isquêmico, acentuando a déficit cognitivo.

▼ Sintomático

Os objetivos do tratamento da DVa são:

- Melhora sintomática dos sintomas-alvo (p. ex., sintomas cognitivos ou comportamentais);
- Retardo na progressão da doença;
- Tratamento secundário dos fatores que afetam a cognição.

Podemos usar:

- Galantamina: melhor para DVa mas com muitos efeitos colaterais, houve alguns benefícios em testagens;
- Donepezila melhor nos CCVa e DVa;
- Rivastigmina pouca evidência;
- Memantina pode haver algum benefício na DVa leve a moderada (ao contrário do alzheimer que usamos na fase moderada/grave);
- Citalopram (melhor), Sertralina (apatia) e Nortriptilina: melhora da labilidade emocional

Demência Frontotemporal

▼ Definição

É uma síndrome caracterizada por alterações progressivas do comportamento, disfunção executiva e linguagem, com atrofia dos lobos frontais e porções anteriores dos lobos temporais (atrofia fronto-temporal importante).

São descritas duas variantes clínicas na DFT:

- DFT com variante comportamental: é a mais frequente;
- DFT com variante de linguagem: pode ser variante semântica e não fluente agramática.

Obs: o comprometimento da memória recente pode ocorrer com o avançar da doença, mas os demais sintomas predominam.

▼ Epidemiologia

A demência frontotemporal (DFTs) é a segunda doença neurodegenerativa primária mais frequente que acomete o cérebro (depois da doença de Alzheimer) em adultos < 65 anos de idade, ou seja, acomete mais jovens.

A DFT variante comportamental é a mais frequente, 60% dos casos. A **média de idade é de 58 anos**, 30% dos casos >65 anos.

A média de sobrevida é de 8 anos a partir dos sintomas, é uma evolução mais rápida que a doença de Alzheimer, por exemplo. Mais nos sexo masculino. Causando mais consultas de psiquiatria.

▼ Fisiopatologia

A DFT é altamente hereditária. Estudos sugerem que 30-50% dos pacientes com DFT tem pelo menos um parente com demência, com um padrão de herança autossômico dominante observado em aproximadamente 10-25% dos pacientes com DFT. Então, a carga hereditária é muito maior do que no Alzheimer, por exemplo.

- DFT com variante comportamental: atrofia dos lobos frontais e porções anteriores dos lobos temporais;
- DFT com variante não fluente agramática: predomínio de região frontoinsular esquerda;
- DFT com variantes semântica: acometimento das porções anteriores dos lobos temporais, mais a esquerda.

Proteínas encontradas nos corpos de inclusão são a proteína tau, TDP-43 e FUS que se depositam nos neurônios e causam lesão cerebral. Sendo mais proeminente:

- DFT comportamental – proteína TAU ou TDP-43;
- DFT não fluente – proteína TAU;
- DFT semântica – TDP-43.

Para que tenha os acúmulos de proteínas, é preciso mutações no gene MAPT (proteína tau associada aos microtúbulos) e no gene PGRN (progranulina), ambos localizados no cromossomo 17, levando ao aparecimento da doença.

As mutações de C9orf72 do cromossomo 9 são causas de DFT familiar e raramente em casos esporádicos.

▼ DFT variante comportamental

Início com alterações de personalidade e de comportamento, com disfunção cognitiva posterior. Presente ≥ 3 dos seguintes sintomas:

- Apatia;
- Desinibição precoce: perdas de boas maneiras, ações impulsivas e descuidadas, social inapropriado;
- Falta de empatia emocional e cognitiva;
- Hiperoralidade (colocar na boca coisas não alimentícias) e alterações de hábitos alimentares: alterações de preferências alimentares, alimentação compulsiva, abuso de álcool ou cigarro, exploração oral de objetos não comestíveis;
- Comportamentos estereotipados: movimentos repetitivos simples (bater palma toda hora, ficar levantando e sentando), comportamentos ritualísticos, compulsivos; estereotipia da fala;
- Alterações da função executivas, relativa preservação de memória (especialmente no início), relativa preservação das habilidades visuoespaciais (consegue tomar banho, sair de casa sozinho).

Obs: é comum os pacientes terem convulsividade em guardar coisas, serem acumuladores, guardarem lixo, por exemplo.

No quadro clínico podem estar presentes alucinações e delírios, além de parkinsonismo e doença do neurônio motor (esclerose lateral amiotrófica, sendo um quadro mais grave e intenso).

▼ **DFT não fluente agramática/Afasia progressiva primária não fluente agramática**

- **Agramatismo**, ou seja, paciente não consegue usar preposições, artigos, pronomes, falta de conjugação dos verbos;
- Redução da fluência verbal;
- Compreensão oral de palavras isoladas preservadas na fase inicial: entende o que é um relógio, mas se falar para ele sair da sala → ir pro estacionamento → ir pro carro → ir embora, ele não entende;
- Mutismo;
- Memória recente preservada

▼ **DFT variante semântica**

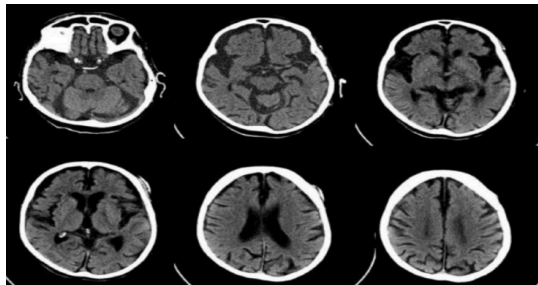
- Perda de significado das palavras, de conceitos e conhecimento de objetos;

- Dificuldade para encontrar palavras;
- Dificuldade de compreensão de palavras isoladas;
- Manutenção das habilidades visuoespaciais e memória autobiográfica;
- Alterações de comportamento são leves em fase inicial: diferindo da forma comportamental.

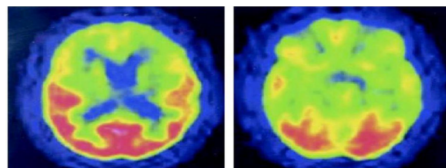
▼ Diagnóstico

▼ DFT variante comportamental

- **Avaliação neuropsicológica:** pelo risco de confusão com um quadro psiquiátrico, como um transtorno obsessivo compulsivo, psicose;
- **Testes de avaliação cognitiva global:** normais em fases iniciais, por isso a necessidade da avaliação neuropsicológica;
- **Testes específicos.** Ex: Bateria de avaliação frontal.
- Coleta do **liquor** para afastar doenças sistêmicas ou infecciosas como neurosífilis, neurotoxoplasmose;
- **RNM de Crânio:** evidencia atrofia dos lobos frontal e/ou temporal, mais a direita na variante comportamental;



- Spect cerebral: hipofluxo na região frontotemporal;
- PET cerebral: hipofluxo na região frontotemporal.



▼ DFT variante semântica

- Avaliação neuropsicológica: comprometimento na nomeação de palavras e prejuízo na compreensão oral de palavras isoladas;
- Comprometimento do teste de fluência verbal (dificuldade de realizar o teste em que tem que dizer o máximo de palavras em 1 minuto), caracterização semântica (selvagens x domésticos) comprometida;
- Conhecimento de objetos afetado;
- RNM de encéfalo: atrofia de predomínio temporais anteriores, muitas vezes assimétrica;
- Spect e PET cerebral.

▼ Afasia primária progressiva não fluente

- Avaliação neuropsicológica: prejuízo na compreensão oral de palavras complexas, preservação das isoladas e do conhecimento semântico de objetos. Bom desempenho em habilidades visuoespaciais e de memória semântica;
- Rnm de encéfalo: atrofia de regiões perisylvianas esquerdas (córtex frontal inferior e insula);
- Spect e PET cerebral: hipofluxo .

▼ Tratamento

Não há tratamento que cure ou modifique a doença, não há medicamentos específicos para essa doença.

Geralmente realizamos intervenções não farmacológicas como fisioterapia, neuropsicológica.

Quanto aos medicamentos possíveis:

- ISRS: pode ser usado para compulsões (alimentar, objetos) e impulsividade;
- Trazodona: para controle dos sintomas comportamentais, como agitação, desinibição, comportamentos perserverativos e insônia;
- Neurolépticos: agitação e agressividade intensa;
- Divalproato de sódio: para euforia, excitabilidade, mania (especialmente de colecionador), impulsividade, irritabilidade e inquietação persistente, agitação e agressão;
- Amantadina: para distraibilidade e inquietação;

- Topiramato: para avidez alimentar e alcóolica.

Além disso, é muito importante auxílio aos cuidadores, rede de Suporte. Sendo cuidados paliativos no fim da vida.

▼ **Prognóstico**

Pacientes com variantes comportamentais progridem rapidamente, ao passo que aqueles com demência semântica progridem mais lentamente.

A sobrevida parece ser mais curta em pacientes com parkinsonismo e naqueles com doença do neurônio motor.

Comparados com pacientes com doença de Alzheimer, os pacientes com DFT têm sobrevida menor e declínio cognitivo e funcional mais rápido.